

Pourquoi l'andropause, la ménopause des hommes, est-elle encore taboue ?

Ce déficit de testostérone, qui touche une partie de la population masculine en vieillissant, reste mal diagnostiqué et soigné.

L'autrice Elise Thiébaut et l'urologue Vincent Hupertan croisent leurs points de vue sur cette période méconnue de la vie des hommes.

Il y a encore plus tabou que la ménopause. Sujet occulté voire banni, l'andropause, ou déficit androgénique lié à l'âge (Dala), touche pourtant de 2 % à 18 % des hommes en fonction de l'âge et de nombreux critères, selon le (Université d'Oxford). Mais ces statistiques sont à prendre avec des pincettes, car « autant la ménopause concerne 100 % des femmes, pour les hommes on n'a pas de chiffres précis sur l'andropause car c'est déclaratif », explique Vincent Hupertan, urologue-sexologue à Paris. Dans tous les cas, ce qui pousse les hommes à consulter, c'est une baisse de la libido et la disparition des érections matinales ». Les autres symptômes ressemblent à ceux, connus (et souvent moqués) de la : bouffées de chaleur, sudation nocturne, troubles du sommeil, prise de poids au niveau du ventre, sentiment dépressif, perte d'énergie... La dysfonction érectile, car on en revient toujours là, reste néanmoins centrale dans le diagnostic : « À partir de 60 ans, tous les hommes ont une érection qui décroît, car ils perdent 1 % de testostérone par an à partir de l'âge de 20 ans. À 60 ans, ils en ont 40 % en moins, ce qui se traduit, pour beaucoup, par des érections moins longues, moins fréquentes, moins dures. Et c'est pire si on fume, si on boit et si on ne fait pas de sport », résume Elise Thiébaut, autrice du livre Ceci est mon corps - Ménopause, andropause et autres aventures climatiques

A lire aussi

Ce délicat problème explique probablement, en partie du moins, le peu d'intérêt médiatique pour le sujet. Selon Elise Thiébaut, le sujet serait même « dix fois moins étudié que son équivalent féminin ». Au niveau éditorial, il existe toujours un vide sidéral autour de la question (alors que sur la ménopause, les langues se sont déliées, les podcasts se sont créés, et les livres ont fini par se publier par dizaines). À part le notable En quête d'érection, l'andropause sans tabou d'Anne-Cécile S. Michelet publié en 2023 (éd. Leduc), quelques ouvrages écrits par des urologues (comme ceux du Dr Marc Galiano) et beaucoup de manuels pour rester performants, on trouve peu de prises de parole d'hommes exposant leurs craintes devant leur premier toucher rectal ou leur désarroi devant une érection mollasse. « Parce qu'ils n'ont pas été habitués à vivre et ressentir les émotions, les sentiments, la vulnérabilité, la plupart des hommes ne savent vivre leur corps vieillissant que dans l'angoisse – celle qu'on prétend n'appartenir qu'aux femmes », écrit Elise Thiébaut. Pour le docteur Hupertan, confronté quotidiennement à ces questions, « c'est plus compliqué de parler d'andropause que de ménopause car c'est lié à la virilité. Or, la sexualité, pour les hommes, est capitale. Quand il n'y a plus de vie intime et érotique, c'est l'équivalent de la mort. On pourrait presque dire : « Je bande donc j'existe »... La baisse de la libido, c'est donc annonciateur de quelque chose de très angoissant. Et qui a envie d'accepter l'antichambre de la mort ? »

Andropause, une étymologie contestée

La question de l'andropause est si complexe que même son étymologie est contestée. Le mot est calqué sur « ménopause », qui signifie l'arrêt des règles. Mais le docteur Hupertan rappelle que « la santé masculine ne connaît pas de pause. On ne peut pas parler d'un arrêt de quelque chose. C'est la raison pour laquelle, médicalement parlant, on lui préférera d'autres termes, comme déficit hormonal lié à l'âge ou Dala, insuffisance hormonale, hypogonadisme masculin tardif... Si on n'a pas de terminologie unitaire pour la définir, le terme qui semble accepté est celui de déficit en testostérone ». Pour Elise Thiébaut, ce tâtonnement pourrait être une façon d'en minimiser les effets. Car dès qu'il est question d'andropause, on rassure les hommes en leur disant qu'il n'y a pas véritablement de drame – la preuve, Robert de Niro a eu un enfant à 79 ans et Mick Jagger à 73... Or, selon l'institut espagnol de gynécologie et d'obstétrique Marquès, donner naissance à un enfant avec un sperme âgé comprendrait aussi une part de risque. « Les bébés conçus avec un sperme vieux ont plus de risques d'être touchés par des maladies auto-immunes, des cancers ou des troubles psychiatriques dans le spectre de l'autisme », écrit Elise Thiébaut.

L'andropause, ce n'est donc ni un mythe ni un sujet léger. S'il est difficile à cerner d'un point de vue lexicologique, il l'est aussi médicalement, car on ne peut pas déterminer avec certitude à partir de quel dosage de testostérone l'andropause est déclarée. « Pour définir le déficit, il n'y a pas de seuil unique. Ni la sexualité, ni la libido, ne peuvent se chiffrer. Ce qui compte, c'est le tableau clinique qui oriente le diagnostic, affirme le Dr Hupertan. Dans la majorité des cas, en plus des troubles de l'érection, il y a des signes généraux : fatigue, humeur dépressive, anxiété voire mal-être intellectuel. Tout ceci peut se déclarer dès l'âge de 40 ans. » Alors que le déficit en testostérone se soigne par une supplémentation, Vincent Hupertan nous apprend qu'aucun de ses patients « ne vient spécifiquement pour l'andropause. Ils savent qu'il faut faire un dosage de testostérone, certains arrivent en consultation en sachant qu'il y aura une exploration de la prostate, mais ils ne s'attendent pas à entendre ce mot ». Les patients concernés recevront alors une ordonnance de TRT, ou traitement de remplacement de la testostérone, qui peut se prendre sous forme de cachet, de gel, de timbre transdermique ou d'implant.

« Le Viagra n'a aucun effet secondaire à part bander comme un âne »

Les résultats sont, paraît-il, rapides et probants. Plusieurs hommes affirment ressentir un réel bien-être dès les premières prises comme « Marc » dans . Après la supplémentation, le patient est suivi régulièrement, « tous les quatre mois au début, puis tous les ans. Les hommes qui présentent un déficit hormonal, le plus souvent, doivent continuer à le prendre toute leur vie », ajoute Vincent Hupertan. Autre incontournable de la pharmacopée moderne, les médicaments de type Viagra (65 millions d'ordonnances prescrites dans le monde depuis vingt ans), qui soignent 89 % des dysfonctionnements érectiles, sont des aides précieuses, comme l'affirme Jean, 67 ans : « J'avais commencé à prendre du Viagra à la fin de la cinquantaine, pour m'amuser. [...] Maintenant, j'en prends de façon sérieuse. Ça n'a aucun effet secondaire à part bander comme un âne. »

Une des raisons pour lesquelles l'andropause est sous-diagnostiquée, c'est tout simplement parce que les hommes vont moins souvent chez le médecin que les femmes. Les campagnes de dépistage pour le cancer de la prostate sont récentes, et les hommes ne sont pas suivis tous les ans, par un médecin spécifique, depuis leur adolescence – sans oublier qu'une fois l'heure venue, l'angoisse de l'examen est pénible pour beaucoup. « Certains transpirent, ils sont au bord du malaise... Il y a beaucoup de mythes et de fausses croyances, beaucoup de complexes avec les parties génitales », confirme Vincent Hupertan.

Des greffes testiculaires pour tenter de redonner l'ardeur des 20 ans

Comment expliquer toute cette crainte, justement, autour de la baisse de la libido et de ses traitements éventuels ? Là où le livre d'Elise Thiébaut fait un pas de côté remarquable sur le sujet, c'est en remontant aux origines historiques de cette peur panique (des mythes à la Bible en passant par Freud) et à ses conséquences. La crainte d'une perte de la virilité a donné lieu, du XVIIIe siècle à nos jours, aux expériences scientifiques les plus fantasques et dangereuses, entre injections d'extraits testiculaires de chien ou de cobaye ou «même du sperme acheté à de jeunes hommes». Au début du XXe siècle, un médecin grec, Skevos Zervos, «entend soigner non seulement l'impuissance, mais aussi l'homosexualité ou la prise de poids» avec des greffes de testicules de chimpanzés (les résultats sont mitigés). De nombreux savants vont tenter des greffes testiculaires pour redonner à leurs patients l'ardeur de leurs 20 ans. Un chirurgien français d'origine russe, Serge Voronoff (1866-1951), fera, par milliers, des transplantations de testicules d'hommes jeunes «dans le scrotum des récipiendaires». Pour trouver des donneurs, il se rabat sur des criminels condamnés à mort, «qu'il déleste de leurs gonades encore chaudes au pied de l'échafaud», comme le résume la plume toujours imagée d'Elise Thiébaut. Ne pouvant répondre à la demande qui le submerge, il se tourne vers les singes – Charles Maurras, le journaliste antisémite et xénophobe à l'origine d'Action française, en aurait bénéficié. Toute la démonstration d'Elise Thiébaut montre les coutures entre des périodes politiquement tendues et ces expériences qui visent à restaurer une virilité affaiblie (voire humiliée) dans une Europe dévastée par la guerre.

Ces liens indissociables entre montée de l'extrême droite, quête viriliste, rêve de puissance et jeunesse éternelle donnent ainsi du grain à moudre à ce paradoxe : là où les femmes doivent accueillir la fin d'un cycle, une certaine partie des hommes luttent pour, comme disait Clint Eastwood, «ne pas laisser entrer le vieux». Or, n'y aurait-il pas une autre voie possible ? «On attend des hommes une performance de tous les instants. S'en libérer a aussi des bienfaits», conclut Elise Thiébaut. A 66 ans, Eugène, photographe, pousse même un cri de soulagement devant le constat, heureux, de la chute de son désir. Artiste, il réalise que ses pensées peuvent enfin vagabonder vers d'autres buts que la conquête permanente. « Quelle paix de l'esprit ! » soupire-t-il. Une façon douce d'accueillir la nouvelle vie qui vient.

(1) Elise Thiébaut, Ceci est mon corps, éd. Au Diable Vauvert, 2024, 20 euros.

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique

[https://www.liberation.fr/resizer/cedKPQUyBYRwrdvSTY8DRS3TMIo=/1200x630/filters:format\(jpg\):quality\(70\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/EQG7ZLHG5VHYTP5GV2DICTBRMM.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/cedKPQUyBYRwrdvSTY8DRS3TMIo=/1200x630/filters:format(jpg):quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/EQG7ZLHG5VHYTP5GV2DICTBRMM.jpg)

par Marie-Eve